YEAR 5 · BLOCK 2 · 3000539 EMERGENCY MEDICINE I

ER & Trauma · คู่มือปฏิบัติงาน

กฎเวร การประเมินผล วอร์ด G-trauma กฎในห้องฉุกเฉิน โซนการทำงาน และหัวข้อที่ใช้สอบ

4	12	22
สัปดาห์	เวร	คน

- 2–29 พ.ย. 2569
- กลุ่ม 8 (C3–C4) · 22 คน
- เลขที่ 9 · TE809 · ศุภณัฐ (Plub)
- ER: ภส.1A · Ward: G-trauma 16A1

01 ภาพรวมรายวิชา

รายการ	รายละเอียด
รหัส / ชื่อ	3000539 EM 1 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 · 2 (1-2-3) หน่วยกิต · Year Course
สถานที่	หอผู้ป่วยฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (ภส.1A) และวอร์ด G-trauma 16A1
ระยะเวลา	4 สัปดาห์ · 2–29 พ.ย. 2569
รูปแบบ	workplace-based learning ภายใต้การกำกับของแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์
ชั่วโมงเรียน	บรรยายออนไลน์ 13 · workshop/discussion 4 · bedside 15 · ปฏิบัติงานคลินิก 49 · SDL 8
รายวิชาที่เรียนร่วม	3000545 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกฯ · 3000505 Chronic & Palliative Care · 3000537 วิทยาการบาดเจ็บ

02 การประเมินผล

เกณฑ์ไม่ชดเชยกัน ต้องผ่าน MPL ทุกส่วน

ความรู้ 40 คะแนน

MCQ 30 ข้อ = 30 · SAQ 5 ข้อ = 10

modified Ebel

สถานการณ์จำลอง 30 คะแนน

OSCE 2 สถานี = 20 · Case discussion (bedside) = 10

modified Angoff

พฤติกรรม 30 คะแนน

Longitudinal observation by residents 15 · On-duty attendance 15

Angoff หรือ 60%

Assignment

IPC for patient safety · S/U · 19 พ.ย. 08.00–12.00

เงื่อนไขการได้ F: คะแนนส่วนใดส่วนหนึ่งต่ำกว่า MPL · แก้ตัวได้ 1 ครั้งต่อการประเมิน (MCQ, SAQ, OSCE) ถ้าแก้แล้วยังไม่ผ่านถือเป็น F
เวลาเรียน: ขาดเกิน 20% ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ · มาสายหรือปฏิบัติงานไม่ครบเวลามากกว่า 1 ครั้ง อาจได้ U ในหัวข้อ professionalism
ความซื่อสัตย์: ลงชื่อแทน ลอกรายงาน ให้ผู้อื่นอยู่เวรแทน หรือบันทึกข้อมูลไม่ตรงความจริง ได้ 0 ในส่วนนั้นและถูกพิจารณาตัดคะแนน

03 เวร

สแกนนิ้วเข้าและออกทุกเวร · หลังลงเวรส่งใบประเมินการปฏิบัติงานให้แพทย์ประจำบ้านเซ็น

วัน	เวลา	โซน	หมายเหตุ
จ. 2 พ.ย.	08.00–16.00	Non-trauma	16.00–24.00 Non-trauma — Orientation 08.15 รับเวรก่อน 08.00
อา. 8 พ.ย.	08.00–16.00	Non-trauma	วันหยุด ไม่ต้องพรีเคส ยกเว้นอาจารย์ปวีณอร
จ. 9 พ.ย.	08.00–16.00	Trauma	16.00–24.00 Non-trauma — วันเดียวอยู่ทั้งสองโซน
พฤ. 19 พ.ย.	16.00–24.00	Non-trauma	มี IPC 08.00–12.00 และ EBM 13.00–16.00 ก่อนขึ้นเวร
ส. 21 พ.ย.	08.00–16.00	Non-trauma	16.00–24.00 Non-trauma — วันหยุด ไม่ต้องพรีเคส
จ. 23 พ.ย.	08.00–16.00	Non-trauma	16.00–24.00 Non-trauma — เช้าวันถัดมาราวน์ 06.45
พ. 25 พ.ย.	16.00–24.00	Non-trauma	วอร์ด 08.00–16.00 ต่อด้วยเวร
พฤ. 26 พ.ย.	16.00–24.00	Non-trauma	ว่างช่วงเช้า มี EBM 13.00–16.00

มาสาย: ต่ำกว่า 10 นาที อยู่เวรเพิ่ม 1 ชั่วโมง · 10–30 นาที เพิ่ม 4 ชั่วโมง · เกิน 30 นาที เพิ่ม 1 เวร · ขาดเวรโดยไม่แจ้ง เพิ่ม 2 เวร
ขาดหรือป่วย: แจ้งคุณสุรชัย 081-5526254 และแพทย์ประจำบ้านหรืออาจารย์ก่อนถึงเวลาเวร
แลกเวร: แลกข้ามโซน trauma กับ non-trauma ไม่ได้ · จำนวนนิสิตต่อเวร 4–6 คน

04 วอร์ด G-trauma 16A1

อังคาร พุธ ศุกร์ 08.00–16.00 · ทั้งกลุ่ม 22 คนต้องอยู่เมื่ออาจารย์มาตรวจ

ราวน์เช้าของกลุ่ม 7–11

06.45–08.00

พ. 4 พ.ย. | ศ. 13 พ.ย. | อ. 24 พ.ย.

การรับเคส

นิสิตปี 5 รับและเล่าเคสคนละ 1 เคส เลือกเคสใดก็ได้ · พี่แพรเริ่มราวน์ประมาณ 07.00–07.15

ลำดับการเล่าเคส

CC → Dx → การผ่าตัดหรือหัตถการ → การรักษาปัจจุบัน → สิ่งที่รออยู่
ไม่ต้องเล่าเป็น SOAP

สิ่งที่ต้องเตรียม

รู้ว่าใครรับเตียงไหน · อย่าขาดราวน์ · อย่าลืมรับเคส · ติดต่อชีพทางเอกเทินเท่านั้น

05 กฎในห้องฉุกเฉิน

การแต่งกาย

ห้ามรองเท้าแตะและกางเกงยีนส์ · นิสิตหญิงใส่กางเกงขายาวปิดข้อเท้า

อุปกรณ์ป้องกัน

สวม mask และ face shield ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน · ของมีคมทิ้งในภาชนะที่จัดไว้เท่านั้น

การถ่ายภาพ

ห้ามถ่ายรูปผู้ป่วยหรือสถานที่ภายในห้องฉุกเฉิน

การสั่งการรักษา

ห้ามสั่งการรักษาโดยไม่มีแพทย์ประจำบ้านหรืออาจารย์กำกับ · หัตถการ invasive ต้องขอ informed consent

Blood gas

ใช้กับผู้ป่วยใน ER เท่านั้น · ใส่ heparin และอุปกรณ์กัน clot · ห้ามส่ง body fluid อื่นหรือเลือดจากวอร์ดอื่น · สแกน barcode ห้าม key HN เอง

การพักอาหาร

ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อเวร · แบ่งกันไป ไม่ปล่อยให้ว่างทั้งทีม

Bedside teaching: จันทร์และพฤหัสช่วงเช้า และช่วงบ่ายของวันทำการตามที่นัดกับอาจารย์ · นิสิตโซน non-trauma เตรียมและนำเสนอ 2–3 เคส · ต้องขออนุญาตผู้ป่วยก่อนพาอาจารย์ไปราวน์
ข้อกำหนด: ต้องนำเสนอเคสกับอาจารย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างน้อย 1 เคสภายใน 4 สัปดาห์ โดยใช้แบบประเมินของฝ่ายฯ · ไม่นำเสนอถือว่าตก

06 โซนการทำงาน

โซน	ที่ตั้ง	เนื้อหาที่ได้ฝึก
Non-trauma + Resuscitation bay	ด้านหน้า	primary survey, การซักประวัติและตรวจร่างกาย, การวินิจฉัยแยกโรค, การสั่ง Lab และ imaging, ACLS, หัตถการ (paracentesis, ABG, NG lavage, ultrasound, RSI), เวชระเบียน

โซน	ที่ตั้ง	เนื้อหาที่ได้ฝึก
Trauma	ด้านหน้า	ATLS, เย็บแผลและใส่เฝือก, procedural sedation, การอ่าน X-ray และ CT, FAST
ER-OU (observation unit, ต่ำกว่า 72 ชั่วโมง)	ชั้น M อาคารภูมิสิริ	การติดตามอาการ การประเมินซ้ำ และการวางแผนรักษาต่อ
Triage	ด้านหน้าสุด	ระบบคัดกรองและลำดับความเร่งด่วน
EMS	ด้านหน้าและชั้น M	การประสานงานกับหน่วยกู้ชีพเอราวัณและนเรศวร

07 หัวข้อที่ใช้สอบ

ตามที่ระบุในเอกสารปฐมนิเทศของรายวิชา

e-lecture (10 หัวข้อ)

- Principle of Emergency Medicine
- Basic & advanced cardiac life support
- Approach to chest pain
- Emergency airway management
- Emergency Medicine Service
- Emergency toxicology
- Approach to dyspnea
- Initial management of shock
- Environmental emergency
- Hypertensive emergency

SDL (9 หัวข้อ)

- Syncope
- Hyperglycemic crisis และ hypoglycemia
- Acute abdomen
- SVC obstruction, hemolytic crisis, incompatible transfusion
- Sepsis
- Anuria/oliguria, urinary retention, hyperkalemia
- Coma, convulsion, increased ICP
- Pneumothorax
- Bleeding in pregnancy, eclampsia

สื่อประกอบ: คอร์ส 3000537.C มีวิดีโอบรรยาย 5 เรื่อง (pediatric trauma, traumatic brain injury, traumatic spine injury, scrub movie, suture & knot) · คอร์ส 3000539 ยังไม่มีไฟล์บรรยายใน Media gallery มีเฉพาะวิดีโอ ACS และ chest pain ของอาจารย์ขวัญศิริ ใน Course Materials

08 ติดต่อ

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	ช่องทาง
ธุรการรายวิชา	คุณสโรชา (พี่เบียร์)	02-649-4000 ต่อ 83058 · 063-797-1033
ประสานงานรายวิชา	อ.นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา	083-0922999 · norawit.k@chula.ac.th
ขาดเวรและเหตุฉุกเฉิน	คุณสุรชัย เพียรเพชรเลิศ	081-5526254 · LINE surachaikun

09 Checklist

- [ ] เตรียมเคสนำเสนอให้พี่แพร (4, 13, 24 พ.ย.)
- [ ] ยืนยันเรื่องใบประเมินการปฏิบัติงานทุกเวรกับแพทย์ประจำบ้าน
- [ ] นำเสนอเคสกับอาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 4 สัปดาห์
- [ ] เข้าร่วม IPC for patient safety 19 พ.ย. 08.00–12.00
- [ ] ตรวจสอบว่ามีวิดีโอบรรยายเพิ่มใน Media gallery หรือยัง
- [ ] ตรวจสอบตารางราวน์และเวลา activity ของอาจารย์ประจำวัน

10 ภาคผนวก · ตารางทบทวน (เสริม)

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ใช้เมื่อมีเวลาในเวรหรือช่วงเช้าที่ว่าง

จ. 2 พ.ย. เวร 08–24	**Principle of Emergency Medicine, EMS** ช่วงที่ผู้ป่วยน้อยใน ER
พ. 3, พ. 6	**Primary และ secondary survey** วอร์ด G-trauma · ATLS บท 1–2
พฤ. 5, ส. 7	**วันว่าง** ไม่มีการกำหนดการอ่าน
อา. 8 พ.ย. เวร 08–16	**Shock, dyspnea**
จ. 9 พ.ย. เวร trauma	**Traumatic brain injury** วิดีโอ 3000537.C · ต่อเนื่องที่วอร์ด 10 พ.ย.
พ. 11 พ.ย.	**Traumatic spine injury** เฉพาะส่วนการตรวจและ clearance
พฤ. 12 – จ. 16	**วันว่าง** ไม่มีการกำหนดการอ่าน
ส. 21 พ.ย. เวร 08–24	**Toxicology, environmental emergency**
จ. 23 พ.ย. เวร 08–24	**Hypertensive emergency, syncope**

พฤ. 26 พ.ย. 08.00–11.00
ACLS และ airway management
ช่วงเช้าที่ว่างก่อน EBM และเวร

ส. 28 – อา. 29
วันว่าง
สิ้นสุดบล็อก

ช่วงทบทวนก่อนสอบ 30 พ.ย. – 23 ธ.ค.

ช่วง	เนื้อหา	ผลลัพธ์
30 พ.ย. – 6 ธ.ค.	SDL 9 หัวข้อ	สรุปหัวข้อละ 1 หน้า: red flag, initial management, ยาหลัก
7–13 ธ.ค.	e-lecture และวิดีโอบรรยายที่ยังไม่ครบ	ทำข้อสอบ MCQ วันละ 20 ข้อ
14–20 ธ.ค.	OSCE และ case discussion	ซ้อมนำเสนอเคส 3 เคส
21–23 ธ.ค.	ทบทวนหัวข้อที่ยังอ่อน	ทำ mock MCQ 1 ชุด

ที่มา: myCourseVille course 89649 · Course syllabus 3000539 ปี 2569 · เอกสารปฐมนิเทศ ER (ไฟล์ปี 2568) · ตารางเวรกลุ่ม 8 แท็บ “22 คน”
ไฟล์ในเครื่อง: `Documents\MDCU\er-trauma\` · ปรับปรุง 1 พ.ย. 2569